

SONDAJE VESICAL

Gonzalo Gutiérrez Carrillo, Isabel Torío Gómez, Marta Molina Bravo.

INTRODUCCIÓN

Una sonda vesical es un tipo de catéter (tubo que se emplea con fin diagnóstico o terapéutico) que se introduce a través de la uretra hasta la vejiga.

INDICACIONES

- Control de diuresis (paciente no colaborador).
- Lavado vesical, continuo o manual, como tratamiento de hematuria macroscópica.
- En caso de trauma vesical que vaya a ser tratado de forma conservadora.
- Tratamiento de la retención aguda de orina.
- Útil en pacientes con incontinencia urinaria por rebosamiento, refractarios a tratamiento médico, en espera a cirugía o no candidatos a la misma (sonda vesical permanente)
- Para realizar instilaciones de sustancias intravesicales, como BCG o Mitomicina C, en pacientes con tumores vesicales recidivantes o de alto grado.

CONTRAINDICACIONES

Nunca debemos sondar a un paciente que presente:

- Infección uretral aguda.
- Prostatitis aguda.
- Sospecha de rotura uretral postraumática.

En estos casos, estaría indicado realizar una talla vesical o cistostomía suprapúbica, la cual siempre debe ser realizada por un médico especialista.

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN TALLA VESICAL

Localizando la vejiga a 2 cm por encima del pubis, se palpa el globo vesical, y tras infiltración de anestésico local, se realiza una incisión en la piel de 1-2cm aproximadamente, a través de la cual se introduce el trócar, mediante el cual introduciremos la sonda. Se debe fijar con seda.

Una talla vesical requiere de mismos cuidados a un sondaje vesical común, con especial importancia de evitar tirones. En caso de obstrucción o infección que precisen recambio de talla vesical, este debe realizarlo un urólogo lo antes posible, por riesgo de cierre de la ostomía.

Podemos encontrar las siguientes complicaciones al sondar a un paciente:

- Realizar una falsa vía uretral: se produce uretrorragia y no salida de orina. Podemos comprobarlo con una jeringa. No se debe forzar un sondaje y debemos avisar al especialista.
- Obstrucción de sonda vesical o de talla, por coágulos o acodamiento de sonda.
- Infección de orina: la sonda vesical permanente es la fuente de infección urinaria más frecuente. No está indicado tratamiento en caso de paciente asintomático. En caso de presentar síntomas, el tratamiento es antibiótico y recambio de sonda.
- Debemos pinzar la sonda cada 250 cc aprox. de orina evacuada, en pacientes con gran retención, para evitar hipotensión, sobre todo en cardiópatas, y la hematuria exvacuo que ocurre tras el rápido vaciado vesical.

MATERIAL

Existen distintos tipos de sonda, que se clasifican en función de su material, el número de vías, el calibre y la forma de la punta, fundamentalmente.

- Según el material, encontramos sondas de látex (baratas, de consistencia blanda y corta duración) y de silicona (mayor precio, más rígidas y mayor duración), principalmente.
- Según el número de vías: 1 vía (rígidas, para sondajes intermitentes o difíciles) 2 vías (una luz para drenaje de orina, la otra para llenado de globo de sonda para anclarla a la vejiga) y 3 vías (una tercera vía para entrada de suero para lavados continuos)
- Según el calibre: El calibre se mide en French (Fr) o Charriere (Ch) (para conocer el diámetro en cm, dividimos entre 3 aproximadamente $1\text{Ch}=0.33\text{cm}$). Hay desde 6 hasta 26 Ch (los más usados en adultos desde el 12Ch hasta 22Ch) y emplean un código de colores universal:

CH06	CH08	CH10	CH12	CH14	CH16	CH18	CH20
							

TÉCNICA

- Asepsia de genitales (en hombres hasta surco balanoprepucial. En mujeres separar labios y limpieza de zona periuretral).
- Guantes estériles y colocación de campo estéril con gasas, lubricante urológico, sonda, y jeringa con suero para llenado de globo.
- Lubricar. En hombres introducir lubricante a través de la uretra.
- Introducir sonda: en hombres, tracción del pene hacia arriba para modificar la curvatura de uretra membranosa.
- Cuando estemos seguros de estar en vejiga, inflar el globo de la sonda.
- Conectar la bolsa a la sonda.
- Importante en hombres recolocar el prepucio para evitar parafimosis.

BIBLIOGRAFÍA

- Carter BH. Instrumentación básica. En Campbell Urología. P Walsh, Retick, Vaughan, Wein (eds.). Ed Panamericana (8.a edición). Buenos Aires, 2005;119-125
- Drenajes y sondas. En libro del residente de urología. J.Guajardo, D.Garcia, J.Pelegri. 2016